BONUS 1

200 Sonuç Cümlesi Bankası

Normal tetkik, insidental bulgu ve acil bulgu için modaliteye ve sisteme göre sıralanmış 200 hazır Sonuç / İzlenim cümlesi. Raporunuzu tek, net ve okuyanın ne yapacağını bildiği bir cümleyle kapatın.

İçindekiler

Sonuç cümlesi nasıl yazılır

Röntgen — 50 cümle

BT — 70 cümle

MR — 35 cümle

USG / Doppler — 45 cümle

Sonraki adım

BAŞLARKEN

Sonuç cümlesi nasıl yazılır

ÖZETLE adımı: klinik soruya yanıt, en önemli bulgu önce, gerekiyorsa öneri ve bildirim.

> *Klinisyenlerin büyük kısmı önce Sonuç bölümünü okur. Bulgular ne kadar iyi olursa olsun, Sonuç belirsizse rapor eksik kalır.*

1. **Önce klinik soruya yanıt verin** — «apandisit?» diye sorulduysa ilk cümle apandisitin var olup olmadığını söylemelidir.
2. **Önem sırasına göre dizin** — acil bulgu her zaman ilk sırada; insidental bulgular en sonda.
3. **Bulguları tekrar etmeyin, yorumlayın** — Sonuç, Bulgular'ın kopyası değil, onların anlamıdır.
4. **Öneriyi spesifik yazın** — «ileri tetkik önerilir» yerine hangi tetkik ve neden.
5. **Acil bulguda bildirimi kaydedin** — kime, saat kaçta, hangi yolla bildirildiği.

Cümle türleri

ETİKET	NE ZAMAN	BU BANKADA
NORMAL	Patoloji yok veya değişiklik yok; değerlendirmenin sınırlılığı.	43 cümle
BULGU	Klinik soruyla ilgili rutin bulgular.	82 cümle
İNSİDENTAL	Rastlantısal bulgu; genel korelasyon veya takip önerisiyle.	26 cümle
ACİL	Hemen bildirilmesi gereken bulgu; bildirim kaydıyla.	49 cümle

Takip aralıkları hakkında

İnsidental bulgu cümlelerinde takip aralığı veya boyut eşiği verilmemiştir. Nodül, adrenal lezyon, kist ve benzeri bulguların takibi hastanın risk profiline ve kurumunuzun benimsediği güncel kılavuza göre belirlenir; emin olmadığınız bir sayıyı rapora yazmayın, hocanıza sorun.

Köşeli parantezler

[sağ/sol], [.. mm], [saat] gibi alanları doldurun ve uygun olmayan seçenekleri silin. Raporda köşeli parantez kalmamalıdır.

BÖLÜM 1

Röntgen

50 sonuç cümlesi, sisteme göre.

Röntgen · Toraks

NO	SONUÇ / İZLENİM	TÜR
001	Akciğer grafisinde akut kardiyopulmoner patoloji saptanmadı.	NORMAL
002	Önceki tetkike göre belirgin değişiklik izlenmedi.	NORMAL
003	Yatak başı grafide yeni gelişen opasite, efüzyon veya pnömotoraks izlenmedi.	NORMAL
004	Tüp ve kateterler uygun konumda; girişime bağlı komplikasyon izlenmedi.	NORMAL
005	[Sağ/Sol] [lob] konsolidasyon; klinik ile birlikte pnömoni ile uyumlu olabilir.	BULGU
006	Önceki tetkike göre [sağ alt zon] konsolidasyonunda belirgin gerileme.	BULGU
007	Önceki tetkike göre [sağ alt zon] konsolidasyonunda artış; klinik korelasyon önerilir.	BULGU
008	[Sağ/Sol] [az/orta/fazla] miktarda plevral efüzyon.	BULGU
009	Bilateral az miktarda plevral efüzyon ve bazal pasif atelektazi.	BULGU
010	[Sağ/Sol] [lob] atelektazisi; santral obstrüktif neden açısından gerekirse BT önerilir.	BULGU
011	Bazallerde lineer (plak) atelektazi.	BULGU
012	Kardiyomegali (PA grafide).	BULGU
013	AP projeksiyon nedeniyle kalp boyutu değerlendirmesi sınırlıdır.	BULGU
014	Pulmoner ödem lehine bulgular; klinik korelasyon önerilir.	BULGU
015	Pulmoner venöz konjesyon bulguları.	BULGU
016	Önceki tetkike göre pulmoner ödem bulgularında gerileme.	BULGU
017	[Sağ/Sol] akciğer [zon] da [.. mm] kitle lezyonu; kontrastlı toraks BT önerilir.	BULGU
018	[Sağ/Sol] [zon] da kaviter lezyon; enfeksiyöz süreçler ve neoplazi açısından klinik korelasyon ve BT önerilir.	BULGU
019	Bilateral yaygın milimetrik nodüler opasiteler (miliyer patern); klinik ve mikrobiyolojik korelasyon önerilir.	BULGU
020	Hiperinflasyon bulguları; KOAH ile uyumlu olabilir.	BULGU
021	[Sağ/Sol] [..]. kosta kırığı; pnömotoraks izlenmedi.	BULGU

NO	SONUÇ / İZLENİM	TÜR
022	Endotrakeal tüp ucu karinanın [.. cm] üzerinde, uygun konumda.	BULGU
023	Santral venöz kateter ucu superior vena kava projeksiyonunda; pnömotoraks izlenmedi.	BULGU
024	[Sağ/Sol] [zon]da [.. mm] nodüler opasite; karakterizasyon için klinik korelasyon ve gerekirse BT önerilir.	İNSİDENTAL
025	Aortada kalsifik ateromatöz değişiklikler.	İNSİDENTAL
026	[Sağ/Sol] pnömotoraks. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
027	[Sağ/Sol] geniş pnömotoraks ve tansiyon lehine radyolojik bulgular. Acil bulgu; [saat]'te telefonla bildirilmiştir.	ACİL
028	Endotrakeal tüp ucu [sağ ana bronş] projeksiyonunda. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
029	Nazogastrik tüp ucu [sağ ana bronş] projeksiyonunda, uygun konumda değil; kullanılmadan önce [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
030	Mediastende belirgin genişleme; travma veya göğüs ağrısı varlığında aort patolojisi açısından acil BT anjiyografi önerilir. [Saat]'te bildirilmiştir.	ACİL

Röntgen · Batın

NO	SONUÇ / İZLENİM	TÜR
031	Direkt batın grafisinde obstrüksiyon veya serbest hava lehine bulgu saptanmadı.	NORMAL
032	Barsak gaz dağılımı olağandır.	NORMAL
033	İnce barsak obstrüksiyonu ile uyumlu bulgular; kontrastlı abdomen BT önerilir.	BULGU
034	Kolonda belirgin fekal yük.	BULGU
035	[Sağ/Sol] [lokalizasyon] projeksiyonunda opak taş ile uyumlu olabilecek dansite; USG veya kontrastsız BT ile korelasyon önerilir.	BULGU
036	Pelviste flebolit ile uyumlu olabilecek kalsifik dansiteler.	İNSİDENTAL
037	Diyafram altında serbest hava (pnömoperitoneum). Acil bulgu; klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
038	Sigmoid volvulus lehine bulgular. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL

Röntgen · Kas-iskelet

NO	SONUÇ / İZLENİM	TÜR
039	[Sağ/Sol] [bölge]de akut kemik patolojisi saptanmadı.	NORMAL
040	Kırık veya çıkık izlenmedi; eklem aralıkları korunmuştur.	NORMAL
041	Kırık hattı izlenmedi; klinik şüphe sürüyorsa okült kırık grafiyle dışlanamaz.	NORMAL

NO	SONUÇ / İZLENİM	TÜR
042	[Sağ/Sol] distal radius kırığı ([eklem içi/eklem dışı], [dorsal] açılanmalı).	BULGU
043	[Sağ/Sol] skafoid [bel] kırığı.	BULGU
044	[Sağ/Sol] [anterior] glenohumeral çıkık; redüksiyon sonrası kontrol grafi önerilir.	BULGU
045	[Sağ/Sol] [lateral malleol] kırığı; mortis [korunmuş/genişlemiş].	BULGU
046	Redüksiyon sonrası kırık fragmanlarında dizilim [kabul edilebilir/bozuk].	BULGU
047	[Sağ/Sol] dizde dejeneratif değişiklikler (osteoartrit); akut kemik patolojisi yok.	BULGU
048	Posterior yağ yastıkçığı işareti; okült kırık açısından ortopedik değerlendirme önerilir.	BULGU
049	[Kemik]'te [.. mm] litik lezyon; karakterizasyon için klinik korelasyon ve ileri inceleme önerilir.	İNSİDENTAL
050	[Sağ/Sol] femur boyun kırığı ([deplase/deplase olmayan]). Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL

BÖLÜM 2

BT

70 sonuç cümlesi, sisteme göre.

BT · Nöroradyoloji

NO	SONUÇ / İZLENİM	TÜR
051	Kontrastsız beyin BT'de akut intrakraniyal patoloji saptanmadı.	NORMAL
052	İntrakraniyal kanama, kitle etkisi veya orta hat şifti izlenmedi.	NORMAL
053	Erken iskemik inme kontrastsız BT'de görülmeyebilir; klinik şüphe sürüyorsa MR-DAG düşünülebilir.	NORMAL
054	Önceki tetkike göre yeni kanama veya kitle etkisinde artış izlenmedi.	NORMAL
055	Yaşla uyumlu serebral atrofi; akut patoloji saptanmadı.	NORMAL
056	Kronik küçük damar hastalığı ile uyumlu olabilecek periventriküler hipodansiteler.	BULGU
057	[Sağ/Sol] [lokalizasyon]da kronik enfarkt ile uyumlu ensefalomalazi alanı.	BULGU
058	[Sağ/Sol] [lob] kitle lezyonu ve vazojenik ödem; kontrastlı beyin MR önerilir.	BULGU
059	[Lokalizasyon] sinüzit ile uyumlu bulgular.	BULGU
060	[Sağ/Sol] [kemik] lineer kırığı; eşlik eden intrakraniyal kanama izlenmedi.	BULGU
061	[Lokalizasyon]da kalsifikasyon içeren ekstraaksiyel lezyon; menenjiyom ile uyumlu olabilir, MR ile korelasyon önerilir.	İNSİDENTAL
062	[Lokalizasyon]da araknoid kist ile uyumlu olabilecek BOS dansitesinde lezyon.	İNSİDENTAL
063	[Sağ/Sol] akut epidural hematom; [.. mm] orta hat şifti. Acil bulgu; klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
064	[Sağ/Sol] akut subdural hematom; kitle etkisi mevcut. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
065	Subaraknoid kanama; anevrizma açısından BT anjiyografi önerilir. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
066	[Sağ/Sol] [lokalizasyon] akut intraparankimal hematom, ventriküle açılım [var/yok]. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
067	[Sağ/Sol] MCA sulama alanında erken akut iskemi bulguları; kanama yok. İnme protokolü kapsamında [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
068	[Sağ/Sol] MCA'da hiperdens arter işareti; akut trombüs lehine olabilir, BT anjiyografi önerilir. [Saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
069	Akut obstrüktif hidrosefali lehine bulgular. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL

NO	SONUÇ / İZLENİM	TÜR
070	[Subfalksin/Transtentoryal/Tonsiller] herniasyon bulguları. Acil bulgu; [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
071	[Sağ/Sol] [kemik] çökme kırığı ve altında [ekstraaksiyel kanama]. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
072	BT anjiyografide [sağ/sol] [MCA M1] segmentinde oklüzyon. İnme protokolü kapsamında [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL

BT · Toraks

NO	SONUÇ / İZLENİM	TÜR
073	Toraks BT'de anlamlı patoloji saptanmadı.	NORMAL
074	BT pulmoner anjiyografide pulmoner tromboemboli saptanmadı.	NORMAL
075	Pulmoner arter opasifikasyonu yetersiz olduğundan subsegmental düzeyde değerlendirme sınırlıdır.	NORMAL
076	[Sağ/Sol] [lob] konsolidasyon; enfeksiyöz süreç ile uyumlu olabilir.	BULGU
077	Bilateral buzlu cam dansiteleri; ayırıcı tanıda enfeksiyöz ve inflamatuvar süreçler yer alır, klinik korelasyon önerilir.	BULGU
078	[Sentrilobüler] amfizem.	BULGU
079	Mediastende patolojik boyutta lenf nodları; klinik bağlama göre değerlendirilmelidir.	BULGU
080	[Sağ/Sol] akciğerde [.. mm] kitle lezyonu ve [hiler/mediastinal] lenfadenopati; doku tanısı açısından klinik değerlendirme önerilir.	BULGU
081	[Sağ/Sol] [lob] da [.. mm] [solid] nodül; takip gerekliliği risk profili ve güncel kılavuza göre klinik ekiple birlikte belirlenmelidir.	İNSİDENTAL
082	Koroner arterlerde kalsifikasyonlar.	İNSİDENTAL
083	Tiroid [sağ/sol] lobunda hipodens nodül; USG ile değerlendirme önerilir.	İNSİDENTAL
084	[Bilateral] akut pulmoner tromboemboli; sağ ventrikül yüklenmesi bulguları [var/yok]. [Saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
085	[Asendan aortayı tutan/tutmayan] aort diseksiyonu. Acil bulgu; klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
086	[Sağ/Sol] pnömotoraks. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
087	Pnömomediastinum; özofagus perforasyonu klinik olarak şüpheliyse ileri değerlendirme önerilir. [Saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
088	[Orta/Fazla] miktarda perikardiyal efüzyon; tamponad açısından acil klinik ve ekokardiyografik değerlendirme önerilir. [Saat]'te bildirilmiştir.	ACİL

BT · Abdomen ve pelvis

NO	SONUÇ / İZLENİM	TÜR
089	Abdomen-pelvis BT'de akut patoloji saptanmadı.	NORMAL
090	Apendiks doğal görünümde; akut apandisit lehine bulgu saptanmadı.	NORMAL
091	Kontrastsız BT'de üriner sistem taşı veya hidronefroz saptanmadı.	NORMAL
092	Önceki tetkike göre [lezyon] da belirgin değişiklik izlenmedi.	NORMAL
093	[Sigmoid] kolonda akut komplike olmayan divertikülit.	BULGU
094	[Sağ/Sol] [distal] üreterde [.. mm] taş ve [hafif] hidroüreteronefroz.	BULGU
095	Akut [interstisyel ödematöz] pankreatit bulguları.	BULGU
096	Akut kolesistit lehine bulgular; USG ile korelasyon önerilir.	BULGU
097	Kolelitiazis; akut kolesistit lehine bulgu izlenmedi.	BULGU
098	Karaciğerde metastaz ile uyumlu olabilecek çok sayıda lezyon; klinik ve gerekirse histopatolojik korelasyon önerilir.	BULGU
099	Hepatosteatoz.	BULGU
100	[Az/Orta] miktarda asit.	BULGU
101	[Lokalizasyon] kolonda duvar kalınlaşması; ayırıcı tanıda inflamatuvar, enfeksiyöz ve neoplastik nedenler yer alır, endoskopik korelasyon önerilir.	BULGU
102	Karaciğer segment [..]'de basit kist ile uyumlu lezyon.	İNSİDENTAL
103	[Sağ/Sol] böbrekte basit kist ile uyumlu lezyon.	İNSİDENTAL
104	[Sağ/Sol] adrenal nodül; karakterizasyon ve takip güncel kılavuza göre klinik ekiple birlikte belirlenmelidir.	İNSİDENTAL
105	[Sağ/Sol] böbrekte [.. mm] karakterize edilemeyen lezyon; ileri değerlendirme için [dinamik BT/MR] önerilir.	İNSİDENTAL
106	Karaciğerde bu tetkikte karakterize edilemeyen [.. mm] hipodens lezyon; gerekirse dinamik MR ile değerlendirme önerilir.	İNSİDENTAL
107	Akut apandisit ile uyumlu bulgular. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
108	Akut apandisit ve [periapendiküler apse/perforasyon] bulguları. [Saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
109	Pnömoperitoneum; [olası lokalizasyon] perforasyonu lehine. Acil bulgu; [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
110	Geçiş zonu [bölge]'de mekanik ince barsak obstrüksiyonu ve iskemi lehine bulgular. [Saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
111	Abdominal aort anevrizması ve rüptür lehine periaortik hematom. Acil bulgu; [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
112	Dalak yaralanması, hemoperitoneum ve aktif kontrast ekstravazasyonu. [Saat]'te bildirilmiştir.	ACİL

NO	SONUÇ / İZLENİM	TÜR
113	Barsak duvarında pnömatozis ve portal vende gaz; mezenter iskemisi açısından acil klinik değerlendirme önerilir. [Saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
114	[Sağ/Sol] obstrüktif üreter taşı ve [perirenal koleksiyon/amfizematöz değişiklik]; enfekte obstrüksiyon klinik olarak şüpheliyse acil değerlendirme önerilir. [Saat]'te bildirilmiştir.	ACİL

BT · Omurga ve kas-iskelet

NO	SONUÇ / İZLENİM	TÜR
115	Servikal vertebra BT'de akut travmatik kemik patolojisi saptanmadı.	NORMAL
116	Ligamentöz yaralanma BT ile tamamen dışlanamaz; nörolojik bulgu varsa MR önerilir.	NORMAL
117	[L1] vertebrada akut görünümlü kompresyon kırığı; spinal kanalda daralma izlenmedi.	BULGU
118	Lomber vertebralarda dejeneratif değişiklikler.	BULGU
119	[Vertebra] korpusunda sklerotik odak; kemik adacığı ile uyumlu olabilir, klinik korelasyon önerilir.	İNSİDENTAL
120	[Seviye] düzeyinde instabil görünümlü kırık/çıkık ve spinal kanalda daralma. Acil bulgu; [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL

BÖLÜM 3

MR

35 sonuç cümlesi, sisteme göre.

MR · Nöroradyoloji

NO	SONUÇ / İZLENİM	TÜR
121	Beyin MR'da anlamlı patoloji saptanmadı.	NORMAL
122	DAG'da akut enfarkt lehine difüzyon kısıtlanması saptanmadı.	NORMAL
123	Kontrast sonrası patolojik kontrastlanma izlenmedi.	NORMAL
124	Önceki tetkike göre yeni veya kontrastlanan lezyon izlenmedi.	NORMAL
125	Kronik küçük damar hastalığı ile uyumlu olabilecek beyaz cevher değişiklikleri; akut enfarkt yok.	BULGU
126	Demiyelinizan hastalık ile uyumlu olabilecek beyaz cevher lezyonları; klinik ve güncel tanı kriterleriyle değerlendirilmelidir.	BULGU
127	[Bölge] de menenjiyom ile uyumlu ekstraaksiyel kitle.	BULGU
128	Hipofiz [mikro/makro] adenomu ile uyumlu lezyon; endokrinolojik korelasyon önerilir.	BULGU
129	[Sağ/Sol] [lob] halkasal kontrastlanan intraaksiyel kitle; ayırıcı tanıda yüksek dereceli glial tümör ve metastaz öncelikli düşünülür.	BULGU
130	Pineal kist ile uyumlu olabilecek kistik lezyon.	İNSİDENTAL
131	[Lokalizasyon] da gelişimsel venöz anomali ile uyumlu görünüm.	İNSİDENTAL
132	[Sağ/Sol] [arter] sulama alanında akut enfarkt. Klinik ekibe [saat] 'te bildirilmiştir.	ACİL
133	Beyin apsesi ile uyumlu bulgular. Klinik ekibe [saat] 'te bildirilmiştir.	ACİL
134	[Sinüs] trombozu. Klinik ekibe [saat] 'te bildirilmiştir.	ACİL
135	Hipofiz lezyonu içinde akut hemoraji ve optik kiazmaya bası; apopleksi açısından acil klinik değerlendirme önerilir. [Saat] 'te bildirilmiştir.	ACİL

MR · Omurga

NO	SONUÇ / İZLENİM	TÜR
136	Lomber MR'da anlamlı patoloji saptanmadı.	NORMAL
137	Disk dejenerasyonu dışında anlamlı bası bulgusu saptanmadı.	NORMAL
138	L [4-5] [sağ paramedian] disk ekstrüzyonu; [L5] sinir köküne bası.	BULGU

NO	SONUÇ / İZLENİM	TÜR
139	C [5-6] disk-osteofit kompleksi ve [sağ] foraminal daralma; kordda sinyal değişikliği yok.	BULGU
140	[L1] vertebrada [akut/subakut] kompresyon kırığı; patolojik kırık lehine bulgu izlenmedi.	BULGU
141	[Vertebra] korpusunda tipik hemanjiyom ile uyumlu lezyon.	İNSİDENTAL
142	[Seviye] düzeyinde epidural tümör yayılımı ile uyumlu olabilecek lezyon ve spinal kord basısı. [Saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
143	[Seviye] düzeyinde büyük disk ekstrüzyonu ve kauda equina köklerine belirgin bası; klinik ile birlikte acil değerlendirme önerilir. [Saat]'te bildirilmiştir.	ACİL

MR · Kas-iskelet

NO	SONUÇ / İZLENİM	TÜR
144	[Sağ/Sol] diz MR'da anlamlı patoloji saptanmadı.	NORMAL
145	[Tam kat] ÖÇB yırtığı ve [lateral kompartman] kemik kontüzyonları.	BULGU
146	[Medial] menisküs [arka boynuz] [oblik] yırtığı.	BULGU
147	Supraspinatus tendonunda [tam kat] yırtık; retraksiyon [.. mm].	BULGU
148	[Sağ/Sol] femur başı avasküler nekrozu; eklem yüzü çökmesi izlenmedi.	BULGU
149	Popliteal (Baker) kisti; rüptür bulgusu yok.	BULGU
150	[Bölge]de kemik iliği tutulumu ve [subperiostal/yumuşak doku] koleksiyon; osteomiyelit ve apse açısından acil klinik değerlendirme önerilir. [Saat]'te bildirilmiştir.	ACİL

MR · Abdomen ve pelvis

NO	SONUÇ / İZLENİM	TÜR
151	Dinamik karaciğer MR'da fokal lezyon saptanmadı.	NORMAL
152	Karaciğer segment [..]'de tipik hemanjiyom ile uyumlu lezyon.	BULGU
153	Koledok distalinde taş (koledokolitiazis) ve safra yollarında dilatasyon.	BULGU
154	[Sağ/Sol] overde basit kist ile uyumlu lezyon; takip gerekliliği klinik ekip tarafından belirlenmelidir.	İNSİDENTAL
155	Pankreasta [.. mm] kistik lezyon; karakterizasyon ve takip güncel kılavuza göre klinik ekiple birlikte belirlenmelidir.	İNSİDENTAL

BÖLÜM 4

USG / Doppler

45 sonuç cümlesi, sisteme göre.

USG / Doppler · Abdomen

NO	SONUÇ / İZLENİM	TÜR
156	Tüm batın USG'de patoloji saptanmadı.	NORMAL
157	Safra kesesi doğal; taş veya akut kolesistit bulgusu izlenmedi.	NORMAL
158	İntra ve ekstrahepatik safra yolları dilate değil.	NORMAL
159	Batın içinde serbest sıvı izlenmedi.	NORMAL
160	Barsak gazı nedeniyle pankreas değerlendirmesi sınırlıdır.	NORMAL
161	Kolelitiazis; akut kolesistit lehine bulgu izlenmedi.	BULGU
162	Safra kesesi çamuru (sludge).	BULGU
163	[Hafif/Orta/Belirgin] hepatosteatoz ile uyumlu görünüm.	BULGU
164	Kronik karaciğer parankim hastalığı ile uyumlu olabilecek kaba ekoyapı ve nodüler kontur.	BULGU
165	Splenomegali.	BULGU
166	Koledok dilatasyonu; neden belirlenemediyse MRCP önerilir.	BULGU
167	[Az/Orta/Fazla] miktarda asit.	BULGU
168	Karaciğer segment [..]'de hemanjiyom ile uyumlu olabilecek hiperekoik lezyon; klinik bağlama göre ileri inceleme önerilir.	İNSİDENTAL
169	Safra kesesinde [.. mm] polip; takip gerekliliği güncel kılavuza göre belirlenmelidir.	İNSİDENTAL
170	Akut taşlı kolesistit ile uyumlu bulgular. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
171	Akut apandisit ile uyumlu bulgular. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
172	[İleokolik] invajinasyon ile uyumlu bulgular. Acil bulgu; [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
173	Karaciğer segment [..]'de apse ile uyumlu olabilecek lezyon. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL

USG / Doppler · Ürogenital ve pelvis

NO	SONUÇ / İZLENİM	TÜR
174	Üriner sistem USG'de patoloji saptanmadı.	NORMAL
175	Skrotal Doppler USG'de bilateral testiküler akım simetrik; patoloji saptanmadı.	NORMAL
176	[Sağ/Sol] [hafif/orta] hidronefroz; [olası neden].	BULGU
177	[Sağ/Sol] böbrekte [.. mm] taş; hidronefroz yok.	BULGU
178	[Sağ/Sol] epididimoorşit ile uyumlu bulgular; testiküler akım korunmuş.	BULGU
179	[Sağ/Sol] böbrekte basit kortikal kist.	İNSİDENTAL
180	Prostat [büyümüş]; klinik korelasyon önerilir.	İNSİDENTAL
181	[Sağ/Sol] testis torsiyonu ile uyumlu bulgular. Acil bulgu; [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
182	Uterin gebelik izlenmedi; adneksiyel kitle ve serbest sıvı ile birlikte ektopik gebelik lehine bulgular. [Saat]'te bildirilmiştir.	ACİL

USG / Doppler · Vasküler

NO	SONUÇ / İZLENİM	TÜR
183	[Sağ/Sol] alt ekstremite derin venlerinde tromboz saptanmadı.	NORMAL
184	Bilateral karotis arterlerde hemodinamik olarak anlamlı darlık lehine bulgu saptanmadı.	NORMAL
185	[Sağ/Sol] [internal karotis] arterde aterosklerotik plak; darlık derecesi kurum kriterlerine göre [derece].	BULGU
186	[Sağ/Sol] yüzeyel ven trombozu ile uyumlu bulgular; derin ven sistemi açık.	BULGU
187	Önceki tetkike göre trombüste [rekanalizasyon/değişiklik yok].	BULGU
188	İnfrarenal abdominal aortada [.. mm] genişleme; takip gerekliliği klinik ekiple birlikte belirlenmelidir.	İNSİDENTAL
189	[Sağ/Sol] [femoropopliteal] segmentte akut derin ven trombozu. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.	ACİL
190	Semptomatik hastada [.. mm] abdominal aort anevrizması; rüptür USG ile dışlanamaz, acil BT anjiyografi önerilir. [Saat]'te bildirilmiştir.	ACİL

USG / Doppler · Boyun ve yüzeyel dokular

NO	SONUÇ / İZLENİM	TÜR
191	Tiroid USG'de patoloji saptanmadı.	NORMAL
192	Boyunda patolojik görünümlü lenf nodu saptanmadı.	NORMAL
193	Tiroid [sağ lob] da [.. mm] nodül; kurumunuzun risk sınıflamasına göre [kategori].	BULGU

NO	SONUÇ / İZLENİM	TÜR
194	Diffüz tiroid parankim hastalığı ile uyumlu olabilecek heterojen ekoyapı; tiroid fonksiyon testleri ile korelasyon önerilir.	BULGU
195	[Bölge] de yumuşak doku apsesi ile uyumlu koleksiyon ve çevresel selülit bulguları.	BULGU
196	[Sağ/Sol] memede basit kist ile uyumlu lezyon.	İNSİDENTAL

USG / Doppler · POCUS ve eFAST

NO	SONUÇ / İZLENİM	TÜR
197	eFAST'ta serbest sıvı, perikardiyal efüzyon veya pnömotoraks lehine bulgu saptanmadı. Negatif eFAST organ yaralanmasını dışlamaz.	NORMAL
198	Bilateral yaygın B çizgileri; interstisyel sendrom ile uyumlu.	BULGU
199	FAST pozitif: [Morison poşunda] serbest sıvı. Klinik ekibe [saat] 'te bildirilmiştir.	ACİL
200	[Sağ/Sol] akciğer kayması izlenmedi ve akciğer noktası saptandı; pnömotoraks lehine. [Saat] 'te bildirilmiştir.	ACİL

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

Sonraki adım

Şimdi Bonus 2 · Uzman Hocanın En Sık Düzelttiği 50 Rapor Hatası'nı açın. Doğru sonuç cümlesini seçmeyi öğrendiniz; şimdi raporun geri dönmesine neden olan hataları tanıyın ve bir daha yapmayın.

Cümleleri tam bir raporun içinde görmek için **Ana materyal · 120 Hazır Rapor Şablonu**'na dönebilirsiniz.